

· 论著 ·

家族性腺瘤性息肉病伴发硬纤维瘤的诊断和治疗

于恩达 楼征 徐晓东 孟荣贵 王颖 金国翔 傅传刚

【摘要】 目的 探讨家族性腺瘤性息肉病伴发硬纤维瘤的诊断和治疗。**方法** 回顾性分析 1995 年 1 月至 2005 年 1 月收治的 6 例家族性腺瘤性息肉病并发硬纤维瘤患者的手术史、临床表现、治疗方法和随访结果,分析总结诊疗经验。**结果** 5 例患者发生硬纤维瘤前有大肠手术史,1 例无腹部手术史。腹部无痛性肿块是最常见的临床表现,6 例均通过影像学检查确诊。手术治疗 4 例,术后 2 例继续服用药物治疗,期待治疗 1 例。术后复发 2 例,1 例出现短肠综合征。6 例患者均存活。**结论** FAP 患者伴发硬纤维瘤并不罕见,应提高警惕,及时发现并治疗。需根据患者全身情况和肿瘤部位,选择合理的治疗方式。

【关键词】 腺瘤息肉病,结肠; 纤维瘤病,侵袭型; 诊断; 治疗学

Diagnosis and therapy of familial adenomatous polyposis with desmoid tumour YU En-da, LOU Zheng, XU Xiao-dong, MENG Rong-gui, WANG Hao, JIN Guo-xiang, FU Chuan-gang. Department of General Surgery 2, Changhai Hospital, Shanghai 200433, China

【Abstract】 Objective To summarize the experience in diagnosis and therapy of familial adenomatous polyposis with desmoid tumour. **Methods** Clinical data of 6 patients with familial adenomatous polyposis and desmoid tumour from Jan 1989 to Jan 2005 were retrospectively analyzed. **Results** Five patients received proctocolectomy and 1 abdominoperineal resection. The most common symptom was progressive painless mass in abdomen. All patients were confirmed by image examination. Four received surgery, 2 were treated by medicine postoperatively and 1 got watchful therapy. Postoperative recurrence developed in two cases and one suffered from short bowel syndrome. All patients were alive at the follow-up. **Conclusions** FAP with desmoid tumour is not a rare condition and we should pay attention to diagnosis and manage this disease entity. A reasonable remedy was selected according to general state of health and location of desmoid tumour which can improve prognosis and quality of life.

【Key words】 Adenomatous polyposis coli; Fibromatosis, aggressive; Diagnosis; Therapeutics

硬纤维瘤 (desmoid tumour, DT) 是一种罕见的良性肿瘤,不会发生转移,但可发生局部浸润性生长。家族性腺瘤性息肉病 (familial adenomatous polyposis, FAP) DT 发病率显著高于一般人群,其诊断治疗往往比较困难。本文回顾性分析了 1989 年 1 月至 2005 年 1 月收治的 6 例 FAP 伴硬纤维瘤患者的临床诊治情况,现报告如下。

临床资料

本组共 6 例,男 2 例,女 4 例,年龄 18 ~ 37 岁,中位年龄 33 岁。5 例有腹部手术史,DT 的发生在术后 2 个月至 5 年,1 例无明确手术史,6 例 FAP 伴腹部 DT 情况见表 1。

表 1 6 例 FAP 伴发腹部硬纤维瘤手术情况

序号	性别	年龄(岁)	手术史(年)	硬纤维瘤生长部位
1	男	35	APR [*] (1989)	腹腔内
2	女	42	IRA [#] (1992)	下腹壁
3	女	34	IRA (1996)	腹腔及盆腔
4	男	33	IPAA ^Δ (1998)	腹腔内
5	女	18	IPAA (2002)	下腹壁
6	女	37	无	下腹壁

注: * APR (abdominoperineal resection): 腹会阴联合切除术。

[#]IRA (ileorectal anastomosis): 末端回肠-直肠吻合术; ^ΔIPAA (ileum J pouch anal anastomosis): 回肠 J 型贮袋-肛管吻合术

例 1 男, 35 岁。因“直肠癌”于 1989 年行 Miles 术。术后 8 个月盆腔局部复发, 肠镜检查: “全结肠息肉近千枚”诊断“FAP”, 行全结肠切除术 + 会阴部肿块切除术, 病理示“转移性腺癌”。1993 年因小肠梗阻行剖腹探查术, 术中发现多发小肠壁及系膜肿

瘤,大小约 7 cm × 5 cm 和 10 cm × 7 cm,遂行肿瘤及部分小肠切除术,剩余近端空肠约 160 cm,术后病理诊断:小肠硬纤维瘤。术后出现短肠综合征,予保守治疗后目前可进半流饮食。随访至今,未发现肿瘤复发征象。

例 2 女,42 岁。1992 年因“FAP”行次全大肠结肠+回肠直肠吻合术。1997 年下腹壁出现无痛性肿块,予手术切除。病理诊断:腹壁纤维瘤。1999 年又发现腹壁包块,位于首次病变部位下方,再次手术切除,病理诊断:腹壁硬纤维瘤。2002 年腹壁近脐周部又有肿块生长,约鸡蛋大小,固定,无压痛,手术扩大切除(距肿块边缘 2 cm),病理诊断:硬纤维瘤,切除肿块边缘阴性。术后随访至今,未发现复发征象。

例 3 女,34 岁。1996 年因“FAP”行次全大肠切除+末端回肠直肠吻合术。2001 年出现下腹部坠胀感伴有下消化道不全性梗阻症状,查体:直肠指诊盆腔内可触及固定无压痛性肿块;盆腔 CT 提示盆腔内 6 cm × 4 cm × 4 cm 占位。术中探查见肿瘤位于腹膜后,有包膜,侵及左侧输尿管,遂完整切除肿块,术后病理:盆腔硬纤维瘤。2003 年复查盆腔 CT 提示盆腔内肿块复发。考虑腹腔内粘连致密,手术切除可能性小,遂采取保守治疗,予口服选择性 COX-2 抑制剂及雌激素拮抗剂药物治疗观察。

例 4 男,33 岁。1998 年因“FAP”行全大肠切除加末端回肠 J 型贮袋肛管吻合术,预防性回肠造口,3 个月后行造口还纳术。2003 年始自觉左下腹隐痛、脐周出现进行性增大肿块。查体脐下可触及 5 cm × 3 cm × 3 cm 大小肿块,固定,无压痛。腹腔 CT 提示“腹腔内肿瘤”。手术探查肿块来源于小肠系膜,固定于后腹壁并累及整个小肠,无法手术切除。予口服选择性 COX-2 抑制剂及雌激素拮抗剂治疗观察。

例 5 女,18 岁。2002 年因“FAP”行全大肠切除加末端回肠 J 型贮袋肛管吻合加预防性回肠造口术,术后 2 个月无意中发现下腹壁无痛性肿块,B 超提示腹壁硬纤维瘤(约 3 cm),半年内肿瘤增大较明显(约 6 cm),此后肿瘤无明显变化,也无临床症状,目前接受观察治疗,其父为本组例 1。

例 6 女,37 岁。既往无手术史,2002 年因 FAP 行结肠切除加回肠直肠吻合术,术中见脐左侧腹壁 3 cm × 5 cm 大小肿块,侵及前鞘及腹膜。扩大腹壁硬纤维瘤切除术,术后恢复良好,病理提示腹壁硬纤维瘤,随访至今,未发现硬纤维瘤复发征象。

结 果

随访时间 23 ~ 192 个月,平均 97 个月。病例 1 术后出现短肠综合征,经治疗后,可进半流饮食,伴轻度营养不良,未发现肿瘤复发或转移征象;病例 2 术后腹壁未发现包块,腹部 B 超检查无占位性病变;病例 3 给予口服药物治疗后未出现肠梗阻表现,定期复查腹部 B 超,提示盆腔内肿块未进行性增大,目前已加大口服药物剂量观察。病例 4 因源于小肠系膜,无法手术切除。口服塞来昔布及雌昔米芬后 6 个月,患者腹部肿瘤缩小,症状减轻,可进行一般的体力劳动。随访观察腹部肿块明显缩小,症状消失,继续长期口服药物,药物剂量相应减少。病例 5 腹壁硬纤维瘤体积无明显变化,无临床症状,目前接受观察治疗。病例 6 目前未发现硬纤维瘤复发征象,未接受任何药物治疗。

讨 论

一、流行病学及病因学

DT 是一种罕见的良性肿瘤,年发病率 2.4 ~ 4.3 人/100 万,约占所有肿瘤的 0.03%。FAP 患者 DT 的发生并不少见。文献报道 FAP 患者行预防性结肠切除术后 10 年 DT 的累积风险率为 16%^[1],FAP 患 DT 的危险率是一般人群的 1240 倍。该病有一定的性别差异,文献报道女性 FAP 患者 DT 发病率高于男性^[2]。本组女:男为 2:1。目前认为与硬纤维瘤发病有关的因素包括遗传易感、创伤以及体内性激素水平。遗传方面 FAP 的责任基因 APC 基因胚系突变可能与 DT 的发生有关。许多报道还发现 FAP 的 DT 有家族聚集性,一个 FAP 家系可有多人患 DT,本组例 1 与例 5 为父女关系。基因连锁检查显示这一现象与 APC 基因突变无关,提示 DT 的发生除 APC 突变外可能还与其他基因突变有关。手术创伤可能是发病的潜在启动因素,FAP 中 68% ~ 83% 腹壁和腹腔内 DT 患者有腹部手术史(大肠切除手术),且绝大多数发生在腹部手术后 5 年内,手术方式与 DT 无关。本组 5 例有各种大肠切除手术史。性激素特别是雌激素一直被认为与 DT 形成有关,女性发病率远高于男性,特别是在青春发育期、妊娠期或使用口服避孕药的妇女中,而绝经后的妇女中发病率相对较低。本组病例有 4 例是成年女性,均未绝经且 3 例有生育史。

二、临床表现和诊断

DT 常表现为生长缓慢、质硬、界限清楚的肿块,

一般每年生长 2~9 cm。FAP 的 DT 50% 位于腹腔内,40% 位于腹壁,只有 10% 位于四肢。腹腔内 85%~100% 位于小肠系膜。这与散发型 DT 有明显不同。散发 DT 49% 位于腹壁,43% 位于四肢,只有 8% 位于腹腔。本组 6 例 DT 皆位于腹壁或腹腔。DT 通常无症状,症状皆因 DT 生长压迫周围组织及器官引起,如产生腹痛腹泻、恶心呕吐等症状^[3]。肠系膜 DT 压迫小肠和输尿管引起肠梗阻和肾积水,压迫系膜血管可导致小肠缺血、坏死甚至穿孔。本组 1 例压迫小肠造成肠梗阻,1 例压迫小肠及输尿管。盆腔 DT 常常会损及小肠贮袋而不得不切除贮袋。腹壁 DT 可通过细针穿刺活检确诊,腹腔内 DT 可在超声引导下细针穿刺活检。为了解腹腔内 DT 的部位、病变范围,与腹壁和腹腔内结构的关系等,CT 是首选检查,它较超声和磁共振成像更理想。磁共振成像在肢体 DT 的诊断和治疗效果监测等方面有明显优势。

三、治疗

硬纤维瘤的治疗争议较大,目前的结果都是基于少数 FAP 伴发和散发 DT 病例的经验之谈,缺乏循证医学的依据和有效方法,特别是腹腔内 DT 的治疗效果极差,死亡率高。随着 FAP 预防性大肠切除的广泛开展,DT 已成为大肠癌外 FAP 的主要死亡原因^[4]。当前 FAP 伴发 DT 的治疗方法主要有手术、COX-2 抑制剂和雌激素拮抗剂,化疗及放疗等。(1)手术治疗:发生于四肢、腹壁的 DT 首选考虑手术切除,手术的并发症较少,特别是 <10 cm、边缘清楚者,手术根治率可达 90% 以上。本组 2 例腹壁硬纤维瘤采取扩大切除术疗效满意。腹腔内 DT 常于小肠系膜及后腹膜广泛生长,侵犯系膜大血管等重要组织器官,根治切除不可能,手术危险性大,手术死亡率可达 60%。术后常出现肠痿、短肠综合征等严重并发症。因此目前已达成共识:对无肠梗阻或严重肾盂积水等并发症的腹腔内 DT,不主张手术,手术应以解除梗阻为目的,如小肠短路术或放置输尿管支架等。本组 1 例因盆腔内肿瘤造成左侧肾盂积水,行手术切除,但术后 2 年又复发,无法手术切除。1 例侵犯整个小肠系膜,手术探查证实无法切除。1 例术后发生短肠综合征。COX-2 抑制剂和雌

激素拮抗剂:非选择性 COX-2 抑制剂主要使用舒林酸,选择性有罗非昔布(rofecoxib)和塞来昔布(celecoxib),抗雌激素药物有三苯氧胺(tamoxifen)和雌昔米芬(toremifen)。塞来昔布较舒林酸的优势是对胃肠道的副作用小,可加大剂量长期服用。COX 抑制剂通过抑制前列腺素合成而对纤维瘤组织发挥“免疫攻击”的作用。女性患者长期使用抗雌激素药物治疗应注意子宫内膜癌的发生。1 例盆腔内术后复发,予 COX-2 抑制剂口服后 8 个月观察,瘤体进行性缩小。(2)放疗化疗:放射治疗用于四肢和腹壁 DT 术后的辅助治疗有一定效果,可降低复发率,但不适用于腹腔 DT,因可产生严重并发症。由于 DT 与纤维肉瘤一样皆来源成纤维细胞,因而治疗纤维肉瘤的化疗药物对 DT 有一定疗效,主要方案是使用阿霉素加氮烯咪胺或卡铂。但这种化疗有较高的并发症和死亡率,多数学者建议只用于那些无法手术切除的对一线药物(舒林酸加抗雌激素)治疗无效的腹腔大 DT。

FAP 伴发 DT 的治疗,我们建议:对位于四肢和腹壁的病例首选手术治疗,复发可考虑再手术。而位于腹腔内的不论大小首先给予一线药物治疗。6 个月复查 CT,如肿瘤缩小或被控制,继续治疗,必要时可持续数年;如肿瘤仍在生长,瘤体广泛,产生明显症状者应考虑加用化疗,使用阿霉素联合卡铂;对生长迅速巨大的开始就可采取一线药物治疗加化疗。腹腔 DT 导致肠梗阻、肠坏死、输尿管梗阻、腹腔脓肿等,方可考虑手术,目的是解除并发症,而非试图切除 DT。

参 考 文 献

- 1 Knudsen AL, Bulow S. Desmoid tumour in familial adenomatous polyposis: a review of literature. *Fam Cancer*, 2001, 1: 111-119.
- 2 Heiskanen I, Järvinen HJ. Occurrence of desmoid tumours in familial adenomatous polyposis and results of treatment. *Int J Colorect Dis*, 1996, 11: 157-162.
- 3 Hartley JE, Church JM, Gupta S. Significance of incidental desmoids identified during surgery for familial adenomatous polyposis. *Dis Colon Rectum*, 2004, 47: 334-340.
- 4 Bulow S. Results of national registration of familial adenomatous polyposis. *Gut*, 2003, 52: 742-746.

(收稿日期:2005-04-11)

(本文编辑:李燕华)